Graham Music, Nature Culturali, Alpes, 2020

Capitolo 6
Attaccamento

Il termine attaccamento è un termine sempre più diffuso anche nel linguaggio quotidiano per descrivere il tipo di legame forte o debole di una persona. Quando invece si parla di *teoria dell'attaccamento* ci si riferisce ad un campo specifico della ricerca scientifica avviato da Bowlby (1969), ampliato poi da molti dei suoi successori, che costituisce adesso un corpus di primaria importanza per gli studiosi dell'area evolutiva. In questo capitolo uno mi concentrerò su tale corpus di ricerca fornendo una prima panoramica, con ampliamenti nei capitoli successivi.

Bowlby, psicoanalista e psichiatra alla Tavistock Clinic di Londra, si rese conto di come avesse bisogno di un nuovo paradigma per riportare la psicoanalisi in linea con il pensiero scientifico oggetto di ricerca a quel tempo ed anche per comprendere i bambini più complessi che incontrava nel suo lavoro. Ad influire notevolmente sulla teoria dell'attaccamento c'erano, oltre alla psicoanalisi e la psichiatria, la teoria evolutiva e l'etologia, lo studio del comportamento degli animali nel loro ambiente di vita. Bowlby apprese che la mancanza di cure materne durante la crescita lasciava profonde cicatrici sui piccoli di molte specie. Tenne in considerazione il lavoro di Harlow (1965) che aveva scoperto che scimmie allevate in isolamento presentavano sintomi sconvolgenti come paura, comportamenti bizzarri, e incapacità di interagire o giocare. Le stesse scimmie, dovendo scegliere tra due esemplari artificiali, si aggrappavano a quella ricoperta di spugna morbida e ignoravano la scimmia in metallo duro, nonostante questa tenesse in mano una bottiglia di latte; si rivolgevano a quest'ultima solo quando avevano fame: il conforto era più importante del cibo. Un altro ricercatore, Hinde (1970), osservò che quando separati dalle proprie madri i piccoli dei primati in un primo momento protestavano, poi mostravano disperazione, ed alla fine si isolavano. Questi dati somigliavano a quelli osservati da Bowlby, che sosteneva che anche i neonati umani sono biologicamente predisposti al necessario legame con una figura protettiva e di attaccamento, e che l'assenza di tale figura causa problemi psicologici.

Bowlby studiò anche i giovani criminali e scoprì che moltissimi di loro erano stati separati dai genitori, o avevano ricevuto cure genitoriali incostanti, o segnate da violenza o da trascuratezza (Slade e Holmes, 2014). Bowlby sosteneva che le madri, o anche le madri sostitute permanenti, sono di fondamentale importanza per i bambini; rischiò addirittura l'im-

popolarità, perché si ritenne che incoraggiasse le madri al loro ruolo di casalinghe piuttosto che a quello di lavoratrici. Ma nonostante tutto, molte delle sue idee hanno ampiamente resistito al vaglio del tempo.

Egli fu tra i primi psicologi a porre l'accento sull'importanza dell'evoluzione, poiché capì che il bisogno di vicinanza con la madre avvertita dai neonati umani era cambiato poco rispetto al nostro passato evolutivo di vicinanza con altri primati. Bowlby rimase colpito nell'osservare come le scimmie separate dalle madri, si aggrappassero ad esse quando le ritrovavano, e dopo un anno dal ricongiungimento, continuassero ancora a mostrarsi più bisognose di contatto e più paurose, e meno esplorative e curiose delle altre di pari età (Yung *et al.*, 1973). Sempre Bowlby e colleghi osservarono pattern simili negli umani. Negli anni sessanta James e Joyce Robertson, presso l'Anna Freud Centre di Londra, filmarono situazioni di separazione dei bambini dai genitori, come nel caso in cui venivano ricoverati in ospedale per interventi di routine, come l'asportazione delle tonsille, senza che fossero ammesse visite. Questi filmati ebbero un impatto notevole sul pubblico, allora ed ancora oggi, giacché mostrano con estrema chiarezza l'enorme stato di stress che vive un bambino piccolo quando è separato dalle sue figure di attaccamento. Anzi, grazie a questi filmati si modificò la pratica ospedaliera: le madri furono invitate a visitare i loro figli ogni giorno e col passare del tempo fu loro consentito di trascorrere la notte in ospedale. I bambini studiati mostravano modelli di comportamento simili a quelli dei primati: all'inizio, erano relativamente composti, nell'attesa che i loro bisogni di attaccamento fossero soddisfatti, ma ben presto protestavano, urlavano e piangevano, per immergersi poi lentamente, ma dolorosamente, in uno stato di disperazione e, alla fine, di totale isolamento.

La teoria dell'attaccamento a questo punto era una sorta di teoria *spaziale*, che dimostrava che più era vicina la figura di attaccamento, più il bambino era felice e rilassato. La figura di attaccamento diventa così una base sicura alla quale tornare quando si è angosciati, e la presenza di questa base sicura dà la fiducia che serve per proiettarsi nel mondo ed esplorarlo. Queste prime ricerche hanno evidenziato l'importanza della vicinanza fisica e le conseguenze causate dalla separazione dalle figure di attaccamento, considerando l'enorme vulnerabilità dei bambini dopo la nascita ed il ruolo centrale delle prime esperienze. Bowlby ha definito **legami affettivi** quei legami che si sviluppano tra genitori e figli, si tratta di legami sociali accompagnati da un potente coinvolgimento emotivo, che si costruiscono nel tempo e durano a lungo. Le idee di Bowlby erano radicali per l'epoca e cozzavano con molte delle concezioni prevalenti sui bisogni dei bambini. È probabile tuttavia che egli sopravvalutasse l'importanza della relazione esclusiva madre-bambino, sottovalutando l'importanza di altre fi-

gure di attaccamento (Hrdy, 2009). Le versioni odierne delle famiglie, per esempio le famiglie nucleari con una mamma isolata e dedita unicamente alla casa, sono diverse dalle famiglie createsi per la gran parte della storia dell'umanità, soprattutto nel periodo dei cacciatori-raccoglitori, quello che Bowlby aveva considerato l''ambiente di adattamento evolutivo' (**EEA**). L'attaccamento si può meglio interpretare come una gerarchia, con la madre al vertice, ma con contributi significativi da parte dei padri, dei nonni, dei fratelli, dei cugini e delle altre persone che si prendono cura di loro.

Seconda fase della teoria dell'attaccamento: Mary Ainsworth e il test della *Strange Situation*, e il Modello Dinamico Maturativo di Crittenden

Nella fase successiva, la teoria dell'attaccamento ampliò la sua portata e complessità; all'idea dell'attaccamento come spazio di contatto, si aggiunse la consapevolezza che non tutti i genitori garantivano la stessa esperienza di base sicura, e che differenti stili genitoriali portavano i bambini ad avere differenti modelli relazionali. Una serie di misure sono state elaborate per valutare gli aspetti dell'attaccamento. Descriverò adesso il test più noto che probabilmente è stato all'origine di questo cambiamento e che fornì un nuovo rigore scientifico alla teoria dell'attaccamento. Si tratta del test della Strange Situation che fu ideato da Ainsworth (1978), una delle prime colleghe di Bowlby. Comunque esiste anche una serie di altri test per misurare l'attaccamento come la *Adult Attachment Interview* (Target *et al.*, 2003), un'intervista semistrutturata ideata per i bambini in età scolare, o lo *story-stem* (Hodges *et al.*, 2003), l'*Attachment Story-Completion Task* (Green *et al.*, 2000) e un insieme di altri test ben descritti altrove (Prior e Glaser, 2006).

All'origine del test della Strage Situation c'è in parte quanto Ainsworth aveva notato che l'aveva colpita: intorno agli otto mesi i neonati iniziano ad aver paura degli estranei e si riavvicinano velocemente alla propria figura di attaccamento quando si trovano vicini ad una persona sconosciuta. L'angoscia per l'estraneo potrebbe derivare da una paura innata dei predatori, come credeva Bowlby, o dalla paura verso gli umani sconosciuti (Hrdy, 2000). Questo test consiste in una semplice procedura della durata di circa venti minuti che ha profondamente influenzato lo sviluppo della teoria dell'attaccamento. La sequenza è la seguente:

- si inizia con una madre ed un bambino di circa un anno che si trovano in una stanza che non conoscono dove sono alcuni giocattoli e al piccolo è permesso di esplorare liberamente;

- poi, uno sconosciuto entra nella stanza e parla con la madre; dopodiché, prova ad interagire con il bambino;
- il genitore lascia la stanza senza farsi notare, e lo sconosciuto cerca di interagire con il bambino;
- la madre ritorna e consola il bambino, ma poi lascia nuovamente la stanza; questa volta anche lo sconosciuto esce dalla stanza, lasciando il bambino da solo;
- a questo punto, la mamma torna di nuovo e prova a consolare il bambino.

L'elemento particolarmente affascinante di questo esperimento è la variabilità delle reazioni dei bambini: alcuni piangono, protestano, e gattonano verso la porta, ma quando la madre ritorna si calmano rapidamente; altri sembrano notare a mala pena che le madri hanno lasciato la stanza; e altri ancora sono molto preoccupati dalla madre sia prima che dopo la separazione e non si rasserenano. In seguito alle diverse reazioni, Ainsworth raggruppò i comportamenti rilevati in tre principali gruppi: uno di attaccamento sicuro (circa il 60% dei campioni non clinici del Maryland osservati da Ainsworth), e due di attaccamento insicuro, ora chiamati attaccamento **evitante** (circa il 25%) ed **ambivalente** (circa il 15%). Parole come *sicuro* e *insicuro* sono rischiose in quanto contengono un giudizio implicito come se tali forme di attaccamento fossero buone o cattive, naturali o innaturali, giudizi di cui dobbiamo essere consapevoli; e Crittenden (1992) ci ha aiutato ad evidenziare questo rischio.

Con il termine attaccamento sicuro si classificarono i bambini, originalmente denominati Gruppo B, che piangevano quando la madre usciva dalla stanza, ma che la accoglievano con sollievo al rientro e a volte con gioia, e che poi ritornavano rapidamente ad uno stato di maggiore rilassamento. I bambini con attaccamento evitante (Gruppo A) erano quelli che *in apparenza* non si accorgevano che la madre lasciava la stanza. Dico in apparenza, perché la ricerca ha dimostrato che a quel punto il loro battito cardiaco accelerava e comparivano altri sintomi fisiologici dello stress, proprio come avveniva nei bambini sicuri, nonostante si mostrassero incuranti della separazione (Sroufe e Waters, 1977). Questa è ora considerata una strategia **deattivante** (Holmes, 2009). È interessante notare che tempo fa in molti pensavano che la reazione migliore fosse quella del bambino evitante, quello che non piangeva, opinione oggi condivisa solo da pochissimi. I neonati con attaccamento ambivalente (Gruppo C) cercavano la madre e si aggrappavano ad essa già prima che uscisse, e quando la madre rientrava, essi rimanevano vigilanti e inquieti, o **iperattivati**.

Ainsworth rilevò una notevole coerenza tra lo stile delle interazioni genitoriali e le reazioni del neonato durante il test della Strange Situation, un collegamento che si è ripresentato identico in tutto il mondo. I genitori di bambini sicuri sembravano sensibili nei loro confronti, rispondevano alle loro angosce, e mostravano una disponibilità coerente. I genitori di bambini insicuri erano generalmente meno reattivi ai bisogni emozionali dei loro figli, mentre i genitori di bambini che presentavano un attaccamento evitante, tendevano a non rispondere a segnali come il pianto, ed erano meno consapevoli delle angosce del bambino. Ai bambini evitanti, serve a poco piangere se nessuno si accorge del loro stato, o peggio, se la loro figura di attaccamento si ritira o si arrabbia quando vede il viso del bambino turbato. Spesso i genitori dei bambini con attaccamento ambivalente sono piuttosto incoerenti: in un momento sono molto disponibili e un momento dopo si mostrano ritirati o angosciati, e dunque i loro figli dovranno tenerli d'occhio da vicino. I bambini con attaccamento ambivalente esplorano di meno, come se non confidassero nell'esistenza di una base coerente e sicura alla quale tornare, e di conseguenza restano più aggrappati, invischiati e sono meno rilassati. È importante ricordare che i bambini di tutti e tre i gruppi sono attaccati alle loro figure di cura, e il loro stile di attaccamento rappresenta la strategia migliore per rimanere vicini a chi li accudisce.

Qualche anno più tardi alcuni ricercatori (Hesse e Main, 2000) s'imbatterono in un gruppo di bambini che non rientrava nelle categorie create originariamente da Ainsworth. Questi bambini avevano spesso sperimentato una genitorialità imprevedibile e traumatizzante, e non erano riusciti a sviluppare una strategia coerente ed efficace per far fronte a tali esperienze spaventose, e dunque si avvicinavano a un genitore, poi magari se ne allontanavano, sbattevano la testa contro il muro, per poi congelarsi o abbandonarsi a comportamenti bizzarri. Il genitore, che dovrebbe garantire conforto o consolazione dalle angosce, era invece e spesso per questi bambini la causa della loro angoscia, perché violento per esempio; e così i bambini non avevano modo di soddisfare il loro bisogno di attaccamento. Questo gruppo fu classificato come disorganizzato da Main e comprende bambini che una volta cresciuti saranno spesso oggetto di preoccupata osservazione da parte degli operatori della salute mentale. Basandosi sulle idee di Main e Hesse, Crittenden (1993) ritiene che questi bambini sono incastrati in un dilemma di tipo evitamento-avvicinamento.

Il test della Strange Situation solitamente studia il modello di attaccamento ad un anno di vita, mentre i mattoncini che costruiranno i tratti di personalità vengono posti molto prima. Beebe e Lachmann (2013) mostrarono che se le madri erano in una relazione essenzialmente di sintonia con

i comportamenti dei neonati nei primi mesi di vita, i bambini a un anno mostravano essenzialmente un attaccamento sicuro, e a due mostravano un affetto maggiormente positivo. Beebe prevedeva il tipo di attaccamento a un anno esaminando il grado di coordinamento reciproco tra la madre e il bambino. È interessante notare come anche il grado di contingenza di un neonato di quattro mesi con uno sconosciuto sia anch'esso predittivo dello stato di attaccamento a un anno, il che significa che i bambini trasferiscono ad altre relazioni lo stile d'interazione che si aspettano, e riescono perfino a suscitare reazioni simili negli sconosciuti. Bambini che saranno classificati come evitanti a un anno, già a quattro mesi guardano e cercano la madre meno di frequente, e riescono a gestire questa situazione solo tranquillizzandosi da soli, per esempio, carezzandosi; è come se i bambini evitanti fossero schiacciati dallo sguardo delle madri, e Beebe, infatti, li descrive con la testa protesa di lato, verso la fuga. I bambini che diventano sicuri mostrano un comportamento completamente diverso: guardano dritti alla loro madre e sorridono con piacere e rilassamento.

Per sopravvivere, i neonati sviluppano strategie di regolazione molto diverse. I bambini evitanti hanno bisogno di auto-tranquillizzarsi e regolarsi molto di più, perché hanno appreso che vi sono poche possibilità di ricevere regolazione emotiva dall'esterno. I bambini con attaccamento ambivalente monitorano gli adulti con molta attenzione, giacché non sanno cosa gli accadrà dopo, e si concentrano molto di più sul mondo esterno piuttosto che su loro stessi. I bambini sicuri si aspettano e sanno di poter contare sul fatto che la madre li regolerà quando ne avranno bisogno.

Queste categorie sono piuttosto ampie e infatti esistono modi più precisi, ma meno conosciuti, di concettualizzarle. Per esempio il Gruppo sicuro B può essere suddiviso in B1, i sicuri riservati, B2 i sicuri inibiti, B3 i sicuri equilibrati e B4 i sicuri reattivi. Questo consente un maggior grado di precisione nel descrivere questi comportamenti. Crittenden (2015) ha sviluppato un sistema alternativo di classificazione dell'attaccamento che tiene conto di un numero maggiore di sfumature. Come Ainsworth, era un'allieva di Bowlby e il suo sistema di classificazione, denominato Modello Dinamico-Maturativo, conquista sempre maggiore spazio.

Crittenden respinge il punto di vista secondo cui alcuni stili sono 'più sani' ed evita parole come 'insicuro' che hanno un sapore di giudizio. Ella suggerisce che le strategie di attaccamento cambiano nel corso della vita con il mutare dei contesti, e sono quasi sempre adattive rispetto all'ambiente del bambino. La migliore opportunità di sopravvivenza deriva dal comprendere come comportarsi al fine di rimanere vicini alle proprie figure di attaccamento, quale che sia il loro stile emotivo come aveva capito anche Ainsworth. Crittenden ha contribuito a rendere più com-

plessa la teoria dell'attaccamento, anche se non possiamo qui illustrarla adeguatamente per mancanza di spazio. Ella descrive, per esempio, bambini con figure di cura compulsive, o troppo accondiscendenti o che mostrano un falso affetto positivo, e ha ideato un metodo ad assi multipli per concettualizzare tratti di personalità complessi soprattutto in risposta al maltrattamento.

Tutti questi schemi adattivi diventano schemi di comportamento non coscienti, quelli che Bowlby chiamò **modello operativo interno** e Crittenden descrive come **Rappresentazioni disposizionali**. I bambini apprendono una strategia che funziona con adulti particolari, per esempio limitando l'espressività emotiva se il genitore non tollera la manifestazione dell'affetto. Questo diventa nelle loro menti un modello non conscio, una rappresentazione interna di sé stessi in relazione con gli altri. Va anche ricordato che i bambini sono in grado di stabilire contemporaneamente stili e relazioni di attaccamento diverse tra loro: ci si potrebbe comportare secondo un modello di attaccamento sicuro con la madre ed evitante con il padre, due modalità che rispondono a figure di cura diverse.

Il modello di attaccamento interno

Mentre la teoria dell'attaccamento inizialmente guardava per lo più ai comportamenti, allontanandosi dall'attenzione psicoanalitica per il mondo psicologico dell'esperienza, il concetto di Bowlby di modello operativo interno ha tuttavia mantenuto vivo l'interesse per gli aspetti psicologici. Un modello operativo interno è una mappa emozionale e delle rappresentazioni, un sistema attraverso il quale le persone imparano a prevedere le risposte altrui e a sviluppare rappresentazioni dei probabili andamenti relazionali. Questi modelli non sono statici, sono influenzati dalle nuove esperienze lette alla luce delle aspettative preesistenti.

Il successivo balzo in avanti della teoria dell'attaccamento si è compiuto grazie all'elaborazione di uno strumento chiamato Adult Attacchment Interview (AAI), che ha ridato centralità al mondo della mente, delle idee e delle rappresentazioni, dando avvio ad una serie di nuove ricerche. Lo strumento fu sviluppato da Main (Main *et al.*, 1985) per misurare alcuni processi di pensiero degli adulti, dimostrando i legami esistenti tra il loro stato mentale e l'attaccamento dei bambini misurato con il test della Strange Situation. Una scoperta rivoluzionaria, che ha mostrato come il modo in cui i genitori si rappresentano e riflettono sulla propria vita influisca sullo sviluppo dei figli e su come i modelli di attaccamento si possono trasmettere da una generazione all'altra.

L'AAI è un'intervista semi-strutturata che richiede circa un'ora per la somministrazione completa; l'obiettivo è *sorprendere l'inconscio*, rivelando caratteristiche importanti del mondo delle rappresentazioni legate all'attaccamento. Si chiede, per esempio, di elencare cinque aggettivi che descrivano la relazione con entrambi i genitori, e di fornire poi alcuni ricordi che spieghino quegli aggettivi. Si chiede inoltre di raccontare episodi che avevano turbato il soggetto nell'infanzia, ricordi di una prima separazione o altre esperienze traumatiche. L'obiettivo è sempre quello di far emergere forti risposte emotive. L'intervista è trascritta accuratamente e la cosa interessante è che viene analizzata in base a scale che non misurano quanto è effettivamente accaduto nell'infanzia descritta ma piuttosto il modo in cui si risponde a queste domande e in particolare la logica interna, la coerenza e il grado di riflessione che emerge dalla narrazione.

Alcuni adulti sono classificati come *sicuri-autonomi*, tendono a produrre narrazioni coerenti e non confuse o contraddittorie, hanno la capacità di riflettere sulla propria vita, di sviluppare un racconto coerente della propria storia, che tiene conto delle esperienze emotive e sono interessati a come altre figure significative possano aver vissuto tali eventi. Questi adulti hanno altissima probabilità di avere figli con attaccamento sicuro (Fonagy *et al.*, 1995).

Gli adulti che risultano *preoccupati*, tendono a dare risposte a tratti piuttosto arrabbiate o confuse, e quando viene chiesto loro di descrivere un evento, per esempio una lite con i genitori, sono capaci di raccontarlo come se fossero catapultati nel passato, al momento esatto in cui l'evento si svolgeva. Quando parlano utilizzano frasi più lunghe e confuse, e danno risposte piene di dettagli ma con scarsa auto riflessione. Questi adulti saranno probabilmente genitori di bambini con attaccamento ambivalente.

Gli adulti che tendono ad avere figli con attaccamento evitante fanno parte della categoria denominata *distanziante*; essi tendono a fornire descrizioni della propria infanzia positive ma molto brevi, ma non sono in grado di fornire esempi a sostegno di questa visione positiva. Hanno ricordi di solito piuttosto limitati ma quando dissotterrano alcuni racconti dalla memoria, questi spesso contraddicono l'immagine rosea iniziale. Ad esempio, un adulto potrebbe dire di aver avuto genitori che si sono presi molta cura di lui e raccontare di essersi perso in un bosco nel quale non era mai stato, senza che per ore qualcuno se ne accorgesse. Non è semplice per queste persone essere in contatto con le emozioni, specialmente con quelle negative.

Il quarto gruppo è quello degli *irrisolti-disorganizzati*. La loro narrazione manca di logica e mostrano scarsa capacità di ragionamento e pensiero bizzarro quando viene loro chiesto di parlare di abusi o traumi. Infatti, le

loro storie svelano spesso perdite o traumi irrisolti. Da genitori tendono ad essere *spaventati e spaventanti* ed è probabile che avranno figli con attaccamento disorganizzato.

Quello che colpisce di questi dati, è che mostrano come la capacità riflessiva dell'adulto può influenzare pesantemente lo stile di attaccamento dei figli. Vorrei sottolineare che non è il tipo di infanzia degli adulti ad essere predittivo, quanto piuttosto la capacità di riflettere sulle esperienze. È più probabile che si abbia uno stile sicuro-autonomo se si sono avute esperienze positive durante l'infanzia; ma non è necessariamente così. Ciò che fa la differenza, pur avendo avuto esperienze negative, è la capacità di mentalizzarle, di riflettervi sopra, di riuscire a riconciliarsi in un certo senso con il proprio passato; questa capacità è chiamata **funzione auto-riflessiva**. Main coniò il termine *sicurezza guadagnata* per descrivere adulti che diventano sicuri nonostante l'infanzia difficile, poiché la sua idea è che queste persone avevano conquistato uno stile di sicurezza grazie ad altri fattori protettivi, come successive esperienze positive con altri adulti (Roisman *et al.*, 2014). Questi risultati hanno dato a ricercatori e a psicoterapeuti la speranza che le prime esperienze di vita non siano troppo determinanti per il futuro.

Trasmissione dell'attaccamento

I bambini con stili di attaccamento differenti hanno una diversa esperienza del mondo. I bambini con attaccamento sicuro si aspettano interazioni positive con gli altri, hanno la sicurezza necessaria ad esplorare, sono tendenzialmente più flessibili, e sanno giocare, sono più capaci di provare empatia, di andare d'accordo con gli altri bambini, di regolare le proprie emozioni, e sono maggiormente in contatto con i bisogni emozionali propri e altrui. Questi bambini sviluppano in generale rappresentazioni interne di sé ottimistiche nella relazione con gli altri e sanno che riceveranno aiuto se ne hanno bisogno.

Quindi, apparentemente, essere sicuri conferisce diversi vantaggi ma può tuttavia essere controproducente se uno dei genitori è abusante o isolato, per cui i figli hanno bisogno di sviluppare altre strategie. I bambini evitanti, per esempio, tengono sotto controllo (deattivano) i propri bisogni allo scopo di rimanere nelle grazie della loro figura di accudimento, nascondono a sé stessi gli affetti dolorosi e non li riconoscono nemmeno negli altri. Il mondo delle loro rappresentazioni è meno ricco, non sono in grado di elaborare una complessità affettiva della stessa portata di quella di un bambino sicuro, e devono proporsi come forti e indipendenti. Di

contro, i bambini ambivalenti sono spesso così angosciati da porre domande in continuazione per evitare l'abbandono, e non sempre riescono ad imparare a regolare i propri bisogni emozionali.

La condizione più difficile, però, è quella in cui si trovano i bambini disorganizzati: hanno sviluppato poche strategie per ottenere una risposta ai propri bisogni di attaccamento; il genitore, la persona che di solito fa sentire un bambino al sicuro, è spesso imprevedibile e, ancor peggio, saranno proprio lui o lei, molto probabilmente, a ferire e turbare il bambino. Questi bambini non sentono di avere un posto sicuro nel quale rifugiarsi, non hanno una strategia logica diversa dall'evitare il pericolo che li minaccia nei secondi immediatamente successivi; pertanto sono a volte imprevedibili, sebbene si sia visto che, paradossalmente, questa mancanza di organizzazione con gli anni porti a sviluppare una personalità molto controllante. La loro percezione è che il mondo non è un posto sicuro, salvo che non siano loro ad avere il controllo, pertanto sviluppano a volte un livello disperato di auto-resilienza o cercano di controllare le altre figure significative della loro vita secondo diverse modalità: con comportamenti aggressivi, con comportamenti di cura compulsivi, e quando queste strategie falliscono essi possono diventare molto imprevedibili.

I ricercatori non conoscono ancora quale sia esattamente il meccanismo in base al quale lo stato mentale dei genitori produce un effetto così marcato sull'attaccamento dei figli (Sette *et al.*, 2015). La teoria più accreditata è che gli adulti classificati come sicuri-autonomi siano genitori più sensibili; sono state, infatti, elaborate diverse scale per misurare la sensibilità dei genitori e la loro funzione riflessiva (Slade, 2005). C'è ancora una sorta di *gap di trasmissione* nella spiegazione esatta di come lo stato mentale dei genitori influisca sull'attaccamento del bambino. Il concetto di mind-mindedness elaborato da Meins (Meins *et al.*, 2012) misura quanti commenti, riferiti alla mente, i genitori fanno rivolgendosi ai figli, e così pare si possa prevedere se un bambino svilupperà un attaccamento sicuro. I genitori che mostrano capacità di mind-mindedness tendono a concentrarsi sullo stato soggettivo dei figli, su ciò che essi provano e pensano, e sui loro vissuti. Se un bambino in età pre-verbale mostra dolore, un genitore che ha sviluppato la mind-mindedness può esprimere ad alta voce ipotesi sul perché sia turbato, dicendo magari: "Oh si, ti è mancata la mamma", oppure "Quel rumore è stato proprio forte e ti ha spaventato". Meins ha mostrato che se il bambino è ripetutamente esposto a riflessioni su uno stato mentale, allora diventa più facilmente consapevole degli stati e processi mentali propri e altrui. In confronto alle madri di bambini sicuri, le madri di bambini con attaccamento evitante tendono a fare relativamente pochi commenti mind-minded, e le mamme di bambini ambivalenti fanno a volte conside-

razioni concernenti gli stati mentali ma spesso non hanno un'idea molto accurata dello stato interno del bambino.

La capacità di capire lo stato mentale del bambino, dunque, è fondamentale. Il numero dei commenti mind-minded che la madre fa su un bambino di sei mesi permette di predire il grado di sicurezza dell'attaccamento ad un anno (Bernier e Dozier, 2003), la capacità di mentalizzazione a 48 mesi (Meins *et al.*, 2003), la teoria della mente (Meins *et al.*, 2013) ed anche la competenza verbale e narrativa a cinque anni. Le conclusioni che si possono trarre sull'importanza dello stato mentale dei genitori sono appassionanti, se non altro perché se abbiamo capito cos'è che *trasmette* l'attaccamento, allora possiamo iniziare a intervenire e aiutare i genitori a sviluppare la mind-mindedness e la capacità autoriflessiva.

Un concetto che ha molti elementi in comune con la mind-mindedness è quello di mentalizzazione, sviluppato da Fonagy e Target (1998) dell'Anna Freud Centre, termine che descrive la capacità di comprendere gli stati mentali propri e altrui, di riflettervi su e di capire che il comportamento delle persone è guidato da fattori psicologici ed emozionali. Ancora una volta si osserva una gamma di concetti derivanti da tradizioni leggermente differenti che descrivono idee molto simili. Il concetto di mentalizzazione è sempre più impiegato nei nuovi trattamenti basati proprio su questo concetto (Bateman e Fonagy, 2004) per gli adulti che soffrono di disturbi di personalità borderline. Fonagy e colleghi considerano la regolazione degli affetti, la mind-mindedness, la funzione riflessiva e la mentalizzazione come concetti collegati tra loro e fondamentali per l'attaccamento.

Bisogna però rendere evidente una leggera contraddizione: mentre l'attaccamento sicuro è collegato alla capacità di mentalizzazione, quando abbiamo sviluppato attaccamento sicuro verso qualcuno, tuttavia, una parte della nostra capacità di mentalizzazione rimane sospesa in relazione a quella persona (Bartels e Zeki, 2004). Il lato più discriminante del nostro giudizio può essere offuscato quando amiamo qualcuno, al quale tendiamo ad accordare più che agli altri il beneficio del dubbio, che è la base di quello che Fonagy chiama **fiducia epistemica** (Fonagy e Allison, 2014).

La teoria dell'attaccamento descrive il modo in cui i bambini si adattano al loro ambiente. Però, nonostante risultati precedenti abbiano mostrato come l'Adult Attachment Interview di una donna incinta sia predittiva dello stato di attaccamento del bambino, non ancora nato, ad un anno di età (Fonagy *et al.*, 1991), lo stato di attaccamento precoce non è necessariamente predittivo dei risultati futuri come si presumeva in precedenza (Beijersbergen *et al.*, 2012). Fortunatamente nel corso della propria vita i bambini continuano ad adattarsi all'ambiente in cui vivono. La continuità tra l'attaccamento nell'infanzia e nell'età adulta è molto variabile, anche

se la sensibilità dei genitori in corrispondenza delle diverse età rimane un buon elemento per prevedere la sicurezza dell'attaccamento nel corso di tutta l'infanzia (Schoenmaker *et al.*, 2015). Mentre sappiamo che l'attenzione affettuosa dei genitori rimane centrale (Chopik *et al.*, 2014) non siamo ancora in grado di capire esattamente i meccanismi che presiedono alla trasmissione intergenerazionale dell'attaccamento o la misura in cui queste esperienze originarie sono predittive.

Per finire, non ho menzionato il temperamento biologico quale fattore causale poiché si sono trovati pochi collegamenti con il tipo di attaccamento. I bambini nati più sensibili e meno capaci di autoregolarsi, forse per ragioni genetiche, sono di sicuro maggiormente a rischio di attaccamento insicuro, e i genitori troveranno questi bambini labili difficili da tollerare. Pare che alcuni geni, come quelli legato all'ossitocina, potrebbero influenzare lo stato di attaccamento a parità di tipo di genitorialità (Raby *et al.*, 2012). Tuttavia queste ricerche sono preliminari, basate su piccoli campioni, e altri ricercatori sollecitano alla cautela, sottolineando che l'evidenza almeno finora, non è necessariamente solida (Roisman *et al.*, 2013). La relazione tra eredità biologica e attaccamento è inoltre indebolita dall'evidenza che l'ambiente esterno di un bambino, sia in presenza di interventi terapeutici o in caso di cambiamenti della situazione familiare, possono modificare lo stato dell'attaccamento. La sensibilità genitoriale rimane l'elemento migliore per predire se un bambino sarà sicuro o insicuro anche se ci potrebbe essere qualche legame tra temperamento e attaccamento disorganizzato (Spangler, 2013). Appare sempre più chiaro sulla base della recente ricerca epigenetica, e come sarà discusso in un capitolo successivo, che alcuni bambini, per ragioni genetiche hanno una maggiore probabilità di essere influenzati sia da buone che da cattive esperienze (Belsky e Hartman, 2014a). Tuttavia nonostante le novità nel campo dell'epigenetica, la sensibilità genitoriale e la mind-mindness rimangono il modo migliore per prevedere lo stato di attaccamento di un bambino.

Teoria dell'attaccamento e cultura

Se è vero che la teoria dell'attaccamento descrive un sistema biologico umano, e dunque quello dei mammiferi, (Panksepp, 2004), come tutte le teorie si limita ad un particolare momento storico e allo specifico contesto culturale e storico dal quale è stata prodotta. Una domanda importante è se la teoria dell'attaccamento possa essere utilmente estesa ad altre culture oppure se nella ricerca è insito un pregiudizio nei confronti degli stili genitoriali che sono considerati migliori in Occidente.

È certamente possibile applicare i concetti e i protocolli, come il test della Strange Situation, a culture diverse. E così facendo si è visto come l'attaccamento sicuro sia la forma più comune di attaccamento, sebbene abbia specifiche varianti culturali. Per esempio i Grossman (2005) hanno scoperto che l'attaccamento evitante era in effetti il più comune nella Germania del nord, ma non in quella del sud. Una situazione simile si è rilevata nei Kibbutz in Israele, per cui tra i bambini che dormono in comunità, e non più con le madri, sembra prevalere l'attaccamento ambivalente (Sagi *et al.*, 1995). In altre culture i bambini semplicemente non ricadono in certe categorie. Tra i Dogon del Mali per esempio l'87% dei bambini è stato classificato come sicuro, nessuno come evitante anche se alcuni bambini con madri spaventate o spaventanti sviluppavano uno stile disorganizzato. È più probabile che i bambini cinesi (Archer *et al.*, 2015) mostrino comportamenti meno evitanti e ambivalenti che non gli americani, e in queste culture interconnesse è meno probabile che la madre lasci il bambino da solo. Le madri coreane per esempio mostravano una maggiore probabilità di seguire i loro piccoli a lungo dopo essersi ritrovati (Jin *et al.*, 2012) e questi bambini mostravano un attaccamento di gran lunga meno evitante.

Che le categorie di attaccamento siano di per sé relativamente ampie è un punto di forza, giacché possono essere applicate in contesti diversificati, ma anche un punto debole quando c'è bisogno di comprendere le sfumature più sottili. Per esempio in Cina, dove l'idea di lealtà filiale è centrale, la relazione di attaccamento con i nonni è fortemente predittiva di una serie di risultati, indipendentemente dall'attaccamento ai genitori (Liu, 2013). Non tutti i bambini sicuri, inoltre, sono uguali; ad esempio i bambini giapponesi classificati come sicuri piangono meno rispetto ai bambini tedeschi quando vengono messi giù dalla madre, sebbene appartengano entrambi alla medesima categoria. In Cina un adulto sicuro potrebbe essere restio a chiedere aiuto o a mostrare i suoi sentimenti, a causa di aspettative culturali, soprattutto nel caso in cui si trovi in una situazione che richiede loro di esercitare un'autorevolezza o aiuto o sostegno nei confronti di altri (Erdman e Ng, 2011), comportamenti che sono considerati evitanti nel modello di attaccamento occidentale.

Inoltre è opportuno chiedersi non solo se i concetti riguardanti l'attaccamento si possono applicare alle diverse culture ma anche se i concetti in sé contengono vizi culturali. Concetti come rispondere con tempestività o sensibilità materna potrebbero avere significati diversi in culture diverse. Rothbaum e Morelli (2005) sostengono l'esistenza di un pregiudizio culturale nel modo in cui la teoria dell'attaccamento valuta l'autonomia, l'esplorazione e l'indipendenza, qualità grandemente apprezzate in Occidente. Alle madri di Porto Rico, in media, sembra interessare di più un'attenzione

calma e rispettosa che non l'autonomia. Il controllo fisico dei bambini potrebbe essere associato ad insicurezza negli Stati Uniti ma a sicurezza nelle famiglie portoricane (Carlson e Harwood, 2003), e allo stesso modo l'interferenza materna fa prevedere l'instaurarsi di attaccamento insicuro negli USA ma non in Colombia, dov'è vero il contrario (Posada e Jacobs, 2001), mentre in Turchia il controllo materno e l'induzione del senso di colpa non è legato all'insicurezza come in Occidente (Sümer e Kağıtçıbaşı, 2010).

Nel prossimo capitolo, il sette, descriverò il diverso valore che le culture attribuiscono all'indipendenza o alla responsabilità sociale: in molte si apprezza la capacità di anticipare i bisogni del bambino. La ricerca sull'attaccamento non misura tale capacità ma la risposta del bambino a un evento che induce angoscia e che si è già verificato, non ad un evento anticipato.

Nonostante tutto vi sono prove inoppugnabili dell'esistenza di un sistema universale di attaccamento sia nei bambini umani che in altri primati. Inoltre, vi è anche evidenza che la sensibilità materna è collegata all'attaccamento sicuro anche in paesi molto diversi tra loro come Colombia, Mali, Cile e altri, che dimostrano che la sensibilità materna è collegata alla sicurezza dell'attaccamento anche quando i test sono siglati e valutati da studiosi di culture diverse. Anche nelle società in cui i bambini sono allevati con uno stile più da comunità e spesso passano da una figura di cura a un'altra, come gli Efe studiati da Tronick, i bambini tendono a mantenere l'attaccamento primario con le proprie madri (Tronick *et al.*, 1992). È vero come dice Keller (2013) che la teoria dell'attaccamento a volte non è riuscita a riconoscere l'importanza delle differenze culturali e alcuni dei suoi cardini, come l'importanza dell'autonomia, sono meno centrali in alcune culture. Nonostante questo, in generale, la teoria dell'attaccamento sembra potersi applicare in modo significativo a tutte le culture.

Attaccamento e suoi disturbi

Non tutti i bambini con attaccamento insicuro hanno una prognosi negativa, sebbene l'attaccamento disorganizzato a un anno, l'ipotesi più preoccupante, sia un buon predittore di patologie psicologiche a diciassette anni (Obsuth *et al.*, 2014). L'attaccamento disorganizzato si presenta spesso associato ad altri fattori di rischio quali povertà, famiglia monoparentale, violenza, uso di alcol e sostanze, residenza in quartieri poveri. È probabile che i bambini disorganizzati risentano di elevati livelli di stress, si mostrino ipervigili, presentino comportamenti *ostili* e/o *impotenti*; l'accudimento che ricevono è spesso insufficiente, confuso, spaventevole, e li fa sentire disregolati. Non riescono a trovare una strategia di coping, poiché

sia l'approccio che il ritiro fanno loro paura. Oltre a tali comportamenti, molti bambini traumatizzati mostrano scarso funzionamento esecutivo, possono apparire iperattivi e perfino presentarsi in modo molto simile a bambini con diagnosi di ADHD (DeJong, 2010). Possono essere fuori controllo ma crescendo diventare sempre più controllanti. Il mondo per loro è un luogo spaventoso di cui non fidarsi, e raramente sono desiderosi di eventi inattesi, piuttosto cercano di evitare il cambiamento e di controllare gli eventi il più possibile. Molti bambini adottati con una storia di abusi mostrano tali pattern, e questo può mettere i genitori molto in difficoltà, anche quelli più sensibili e disponibili alla sintonia.

Questi bambini hanno spesso dovuto disattivare i comportamenti di attaccamento per sopravvivere, isolandosi da quello che succede dentro di loro, usando difese estreme come attacco, fuga o **dissociazione**; quando qualcosa fa paura, pare che non ci sia nessuno in grado di dare significato a quest'esperienza. Questi bambini spesso interrompono all'improvviso l'elaborazione di un pensiero, la loro mente inizia a vagare e non riescono a seguire stabilmente un unico binario mentale, processo simile a quello riscontrato spesso nei racconti confusi resi dai loro genitori durante l'Adult Attachment Interview. Finiscono per presentare deficit delle capacità cognitive, a gestire le relazioni e a regolare le emozioni, e difficoltà a sviluppare strategie interpersonali coerenti. Molti sono bocciati a scuola e crescono seguendo traiettorie evolutive preoccupanti, che spesso conducono a problemi giudiziari, psichiatrici o con i servizi sociali.

In questo periodo si parla molto di **disturbi dell'attaccamento** ed è importante chiarire subito che l'attaccamento disorganizzato è una categoria di ricerca. Il disturbo dell'attaccamento è nato come classificazione psichiatrica ufficiale per descrivere bambini che erano stati cronicamente trascurati o la cui carenza di cura derivava dal fatto di non aver mai sviluppato una relazione di attaccamento con una figura di cura in particolare. L'ultima versione del manuale psichiatrico, DSM5, distingue il **Disturbo Reattivo dell'Attaccamento**, in riferimento a casi seri di trascuratezza, come quelli di alcuni bambini cresciuti in orfanotrofi deprivanti, dal Disturbo da Impegno Sociale Disinibito (DSED) per i casi di bambini più disregolati. Sono molti a sostenere che queste categorie mancano di comprensione evolutiva e molti hanno cercato senza successo di proporre una nuova categoria, **Disturbo Traumatico dello Sviluppo** (van der Kolk, 2014) da inserire nel DSM5. Bisogna essere cauti, però, poiché è in corso una discussione tra scienza e psichiatria su questo disturbo; ma come hanno denunciato Prior e Glaser (2006), esiste una sorta di industria che offre versioni volgarizzate delle terapie dell'attaccamento e usa questa diagnosi in modo piuttosto difforme dalla psichiatria ufficiale. Tra queste, le più

controverse sono le cosiddette terapie di *holding*, che cercano di migliorare l'interazione utilizzando forme di contatto forzato tra adulti e bambini, e che sono state molto criticate (Simmonds, 2007) perché realmente pericolose, quando non addirittura causa di incidenti mortali (Lilienfeld, 2007). Questo è in radicale contrasto rispetto a ponderate applicazioni della psicoterapia da parte di clinici con profonda comprensione della teoria dell'attaccamento come scienza (Holmes, 2014). Ad alcuni bambini, che presentano attaccamento disorganizzato, viene anche diagnosticato un Disturbo Reattivo dell'Attaccamento o un Disturbo da Impegno Sociale Disinibito, ma queste due categorie non sono contigue, sebbene sia ormai evidente che le implicazioni a lungo termine per i bambini con attaccamento disorganizzato, e per quelli con un disturbo reattivo dell'attaccamento, non sono buone.

Punti chiave:

- la teoria dell'attaccamento nacque come teoria spaziale e comportamentale che sottolineava l'importanza per i bambini della vicinanza ad una base sicura offerta da una o più figure di attaccamento;
- essa quindi divenne sempre più sensibile alla qualità e al tipo di genitorialità;
- ricerche successive hanno dato importanza crescente allo stato mentale della figura di cura e la sua relazione con il tipo di attaccamento del bambino;
- tutti gli stili di attaccamento possono essere interpretati come adattivi all'ambiente in cui si sviluppano, compresi quelli insicuri;
- la categoria più preoccupante, con la prognosi peggiore è l'attaccamento disorganizzato, spesso riscontrato insieme al trauma e all'abuso;
- un bambino con relazioni di attaccamento sicuro di solito ha vantaggi, come interagire bene con i suoi pari, giocare in modo creativo, comprendere le emozioni e le menti, ed è in grado di regolare meglio le proprie emozioni;
- i meccanismi di trasmissione dell'attaccamento sembrano dipendere dalla sensibilità dei genitori, il che è espresso bene dal concetto di mind-mindness genitoriale;
- la teoria dell'attaccamento ha un significato transculturale, anche se alcuni dei suoi concetti hanno un taglio prettamente eurocentrico;

- vi sono teorie collegate ma differenti da quella dell'attaccamento, come quella del Disturbo Reattivo dell'Attaccamento o i diversi interventi terapeutici che dichiarano un legame per comprendere l'attaccamento;
- gli stili di attaccamento non sono scolpiti nella roccia e possono cambiare in seguito a nuove esperienze e nuove forme di relazioni, una speranza per professionisti e genitori.